

PREPARE MON CONCOURS

Résumé 18

Planification Stratégique



06 16 03 08 31



slit-anass

ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT

INTRODUCTION

La planification de la santé connaît de multiples définitions, variables selon les acteurs qui y sont impliqués. Elle peut bien signifier un processus d'action en santé publique qu'une méthode de résolution de problèmes ou qu'un moyen de régulation ou de maîtrise des dépenses.

La planification est l'une des quatre fonctions classiques du processus de la gestion : Planification, Organisation, Direction, Contrôle (PODC).

La planification fournit l'aide à la prise de décision.

C'est un processus dynamique tourné vers l'action, le changement et le futur.

La planification exige des habiletés multiples :

- ❖ **Techniques** : analyse, projection, conception d'intervention, résolution de problèmes, budgétisation, évaluation... ;
- ❖ **Politiques** : reconnaissance des enjeux, des rapports de force, des enjeux de pouvoir ;
- ❖ **Négociation** : recherche d'un accord centré sur des intérêts ou des enjeux quantifiables entre deux ou plusieurs interlocuteurs ;
- ❖ **Communication** : moyens et techniques permettant la diffusion d'un ou de plusieurs messages.

Le point de départ de toute démarche de planification en santé, qu'elle porte sur les services ou les programmes de prévention ou de soins est la santé. Goldberg classe la majorité des définitions de la santé selon les modes d'abord suivants :

Un abord perceptuel, qui définit la santé comme étant une perception de bien être (la définition de l'OMS est basée sur ce concept)

Un abord fonctionnel, qui décrit la santé comme étant la capacité de bien fonctionner

Un abord qui utilise le concept d'adaptation à l'environnement

La planification est un instrument de gestion : la gestion consiste à l'intégration d'un ensemble de fonction composites

Fonctions de base sont :

Planifier : Etablit les objectifs et détermine comment les atteindre

Organiser : Structure les taches et affecte les ressources en vue d'atteindre les objectifs

Diriger : Motive l'équipe pour atteindre les objectifs souhaités

Contrôler : Mesure le rendement et prend les dispositions pour atteindre les résultats escomptés

Méthode PDCA (PLAN, DO, CHECK, ART) : socle de l'amélioration continue, une méthode pour améliorer la performance d'une organisation

La planification est un processus d'aide à la décision

- ❖ Il vise, par concertation des acteurs concernés,
- ❖ À prévoir des ressources et des services requis
- ❖ Pour atteindre des objectifs déterminés,
- ❖ Selon un ordre de priorité établi,
- ❖ Permettant ainsi le choix d'une solution préférable parmi plusieurs alternatives.
- ❖ Ce choix prend en considération le contexte et les contraintes internes et externes connues actuellement ou prévisibles dans le futur.

Planifier :

- ❖ C'est choisir, donc c'est décider, c'est aussi prévoir et tenir compte du futur dans la prise de décision
- ❖ Planifier c'est changer, c'est donc un ensemble d'effort délibéré pour modifier une situation dans le but d'atteindre dans le futur certains fins souhaitables
- ❖ Planifier c'est appliquer un processus qui amène à décider
 - Quoi faire ?
 - Comment le faire ?
 - Comment évaluer ce qui sera fait avant de le faire ?

La planification sanitaire

La planification sanitaire est « un processus continue de prévision de ressources et de services requis pour atteindre des objectifs déterminés selon un ordre de priorités établi, permettant de choisir la ou les solutions optimales parmi plusieurs alternatives ; ces choix prennent en considération le contexte de contraintes, connues actuellement ou prévisibles dans le futur » Les approches de planification

Les approches de planification sont conçues pour permettre l'adaptation de l'outil de planification au contexte et au domaine étudié :

- ❖ **La planification opérationnelle** met en œuvre des choix et programmes d'action, qui sont les résultats des approches précédentes ; c'est le court terme : déroulement, exécution et suivi des activités. Décisions à court terme quant à déroulement des activités, calendrier d'exécution, gestion des ressources.
- ❖ **L'approche tactique ou structurelle** s'occupe de l'agencement, de l'organisation et de l'encadrement des activités et des ressources ; elle vise le moyen terme et répond aux questions : avec quels moyens ? et selon quel agencement ? Agencement, organisation, programmation d'activités et ressources afin d'atteindre les objectifs fixés (en principe au niveau de la planification stratégique).
- ❖ **L'approche normative (ou politique)** trace les grandes orientations à suivre, s'inspire des valeurs de la société ou les propose comme objectifs de changement ; elle vise le long terme. Concerne la mission d'un organisme, ministère etc. : l'orientation générale ; Vise le changement de valeurs ou d'idéologie dans le but d'atteindre certains grands objectifs
- ❖ **L'approche stratégique** décide des priorités d'action et des choix entre les différentes orientations qui seront prises dans le futur ; elle vise le long terme et répond aux questions : quoi faire et pourquoi ? Priorités d'action, d'orientations. Décision importante, à long terme et Prend en compte les éléments de l'organisation et de l'environnement

TYPE	DURÉE	BUTS/OBJECTIFS	LIVRABLE
NORMATIVE	+10 années	Mission/ valeurs	Politique
STRATÉGIQUE	5 - 10 années	Orientations et priorités - buts	Plan
TACTIQUE	3 années	Ressources et activités, objectifs généraux	Programme
OPPERATIONELLE	1 année	Développement des activités, objectifs spécifiques, objectifs opérationnels	Plan de gestion

La planification stratégique est la formalisation du passage des intentions et des discours à l'action, c'est-à-dire de l'énoncé politique aux plans de mise en œuvre.

Elle se déroule selon :

3 temps

- Temps politique : L'art de gouverner c'est-à-dire l'aptitude de répondre aux aspirations fondamentales d'une collectivité.
- Temps stratégique : L'art de la mise en œuvre des moyens pour la réalisation d'une fin.
- Temps tactique : L'art du passage à l'acte.

2 mouvements :

- Le passage du politique au stratégique, c'est le passage du dire au faire-faire.
- Le passage du stratégique au tactique, c'est le passage du faire-faire au faire.

Dimensions de la stratégie (5P de Mintzberg)

Planification (Planification) : La planification stratégique est le processus par lequel une organisation élabore des plans détaillés pour atteindre ses objectifs à long terme, Cela implique la fixation d'objectifs, l'analyse de l'environnement, la définition de stratégies pour atteindre ces objectifs.

Position (Positionnement) : Le positionnement stratégique consiste à déterminer comment une organisation se place sur le marché par rapport à ses concurrents. Cela inclut des décisions sur les segments de marché à cibler, les produits ou services à offrir, et comment se différencier des autres acteurs du marché.

Perspective (Perspective) : La perspective stratégique concerne la vision à long terme de l'organisation. C'est la manière dont l'entreprise envisage son avenir, ses valeurs fondamentales et sa mission. La perspective stratégique guide les décisions et les actions à long terme de l'organisation.

Pattern (Modèle) : Le modèle stratégique fait référence aux schémas ou aux tendances qui émergent au fil du temps. Mintzberg a souligné que les stratégies réelles d'une organisation peuvent souvent être observées dans ses actions passées, plutôt que dans des plans formels.

Ploy (Manœuvre) : La manœuvre stratégique consiste à utiliser des tactiques ou des actions spécifiques pour atteindre des objectifs à court terme. Il s'agit de réagir aux opportunités ou aux menaces de manière agile et flexible, en adaptant la stratégie au fur et à mesure que la situation évolue.

Objectifs de la Planification Sanitaire

- ❖ Clarifier les rôles et partager la vision, la mission, les objectifs et les activités
- ❖ Résoudre des problèmes et satisfaire des besoins
- ❖ Améliorer les résultats et rationaliser l'utilisation des ressources
- ❖ Fournir un point de référence permettant de mesurer les progrès Planification sanitaire

La planification est un processus méthodologique consistant

- ❖ À définir un problème pour analyse,
- ❖ À repérer les besoins et demandes non satisfaits qui constituent le problème,
- ❖ À fixer des buts réalistes et atteignables et en déterminer l'ordre de priorité,
- ❖ À recenser les ressources nécessaires pour les atteindre
- ❖ À projeter les actions administratives en posant les diverses stratégies d'interventions possibles pour résoudre le problème

Le processus de planification

La planification est d'abord un processus d'aide à la décision qui peut être découpé en trois étapes :

1. **La première étape** est la recherche d'un consensus sur les buts ou finalités, par exemple : diminuer la mortalité maternelle et néonatale.
2. **La seconde étape** est la définition d'objectifs spécifiques prioritaires. Cette étape implique l'identification des problèmes de santé et de leurs déterminants, les personnes concernées (populations cibles), la localisation géographique (nationale, régionale, communale, etc.).
3. **La troisième étape** est la programmation des moyens et des activités nécessaires à la réalisation des objectifs. Elle doit définir le calendrier et les conditions permettant la mise en œuvre des actions décidées (s'attaquer notamment aux obstacles) et évaluer les actions en termes de procédures et de résultats.

Planification normative et stratégique : recherche d'un consensus sur les buts ou finalités

- Identification des problèmes
- Établissements des priorités
- Fixation des buts

Planification tactique ou structurelle : définition d'objectifs spécifiques prioritaires

- Fixation des objectifs généraux et spécifiques
- Détermination des actions
- Prévision des ressources requises

Planification opérationnelle : programmation des moyens et des activités

- Fixation des objectifs opérationnels
- Mise en œuvre du programme
- Évaluation

Outils de collecte et d'analyse des données

L'identification des besoins de la population constitue le point de départ d'un exercice de planification, « le besoin étant la traduction, par le professionnel, de la demande ou de la plainte de la population ».

C'est aussi le passage, la conversion ou la traduction du « problème de santé » mesuré par un indicateur (direct ou indirect) en « besoin de santé ».

D'où la nécessité d'une approche multidisciplinaire et participative où le rôle joué par le planificateur est primordial dans la mesure où il sera capable d'uniformiser l'information et la structurer.

Il existe deux approches complémentaires pour collecter et analyser les données :

- ❖ **Approche populationnelle** : diagnostic communautaire, aboutit à l'identification des besoins et des problèmes de la communauté ;
- ❖ **Approche organisationnelle** : analyse systémique qui aboutit à l'identification des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'organisation (SWOT analysis ou analyse FFOM).

Adéquation demande /offre /besoin

- **Besoins / Demandes** : demande exprimé, besoins existant mais service non disponible : mécontentement et détérioration de la santé de la population
- **Demandes / Offres** : demande exprimé, service disponible mais pas de besoins réels : gaspillage inefficacité
- **Besoins / Offres** : service disponible, besoins exprimés mais pas de demande manifestée : sousutilisation des services
- **Besoins / Offres / Demandes** : équilibre mais très faible

Canevas d'élaboration d'un PA

❖ Analyse de la situation

1. Environnement interne

- **Forces** (atouts internes) qui permettent de réaliser ce que l'on a prévu. Identifier et évaluer les forces qui permettent de réaliser les stratégies
- **Faiblesses** (limites internes) entravent l'atteinte des résultats. Identifier et évaluer les faiblesses qui limitent les capacités.

2. Environnement externe

- **Opportunité** : Élément ou domaine d'action permettant de développer l'institution, le système.
- **Menace** : correspond à un problème posé, une perturbation de l'environnement externe pouvant avoir une tendance défavorable sur l'organisation. Celle-ci est d'autant plus importante qu'elle nuit fortement et qu'elle a des chances de se réaliser.

❖ Détermination des priorités

1. Priorisation des problèmes

- **Matrice multicritère** : Ampleur du problème, Gravité du problème, Vulnérabilité du problème, Faisabilité des solutions

2. L'Analyse des problèmes identifiés

- **La Méthode des 5 "pourquoi ?"** : En matière de résolution de problèmes et pour rechercher rapidement les causes racines. Un process simple à mettre en œuvre. Il s'agit de la méthode des 5 pourquoi
- **L'arbre à problème** : L'arbre à problème vise à identifier un problème central, ses effets et ses causes ; l'arbre des objectifs vise à identifier les solutions pour résoudre le problème central
- **Méthode Ishikawa** : La méthode d'Ishikawa utilise une représentation graphique (diagramme) en forme de poisson « diagramme en arêtes de poisson », pour matérialiser de manière structurée le lien entre les causes et leur effet
- **Méthode de Pareto** : Le diagramme de Pareto est également appelé méthode ou règle des 80/20 (20% des causes produisent 80% des effets). Le diagramme de Pareto est un graphique à colonnes qui présente les informations par ordre décroissant et fait ainsi

ressortir le ou les éléments les plus importants qui expliquent un phénomène ou une situation.

❖ **Fixation des objectifs**

Caractéristiques (SMART+2). Il doit être :

- **Spécifique** : il exprime de façon précise le résultat que l'on cherche à améliorer ;
- **Mesurable** : L'objectif est quantifié et s'exprime selon une unité de mesure.
- **Atteignable** : Les ressources et les moyens doivent être en cohérence avec l'ambition et l'objectif à atteindre.
- **Raisonné** : L'objectif poursuivi est ancré dans le réel. Les actions déployées pour l'atteindre sont plausibles et réalisables au regard de l'environnement.
- **Temporalisé** : l'objectif est borné dans le temps.
- **Fédérateur** : l'objectif doit emporter l'adhésion à la fois de ceux qui contribuent à l'atteindre.
- **Constructif** : l'objectif sert directement les autres objectifs de la stratégie exprimée dans le plan d'actions

Objectif Général : Correspond à l'état de santé désiré et qui a un lien direct avec le but du programme ou la mission de l'organisation ; Il vise le long terme (5 à 10 ans)

Objectif Intermédiaire : Il couvre une partie de l'Objectif Général. Il vise le moyen terme : 3 à 5 ans. Il est quantifié.

Objectif Spécifique : Un niveau inférieur de résultat recherché, plus précis. Il peut correspondre à un service permettant d'atteindre l'objectif intermédiaire. Il vise le court terme : 1 an

Objectif Opérationnel : Il est exprimé en termes d'activités, de tâches, ou de ressources à mobiliser. Il vise le très court terme

❖ **Identification et Agencement des activités**

❖ **Détermination des besoins en Ressources**

❖ **Mise en œuvre du PA**

❖ **Suivi et Evaluation**